大橋病院経営戦略提言書

東邦大学医療センター大橋病院

2025年度2月実績（2026年3月戦略会議資料）

作成日: 2026年3月28日

大橋病院 経営戦略提言書

― 法人経営環境を踏まえた中期経営戦略 ―

作成日: 令和8年4月11日
対象: 東邦大学医療センター大橋病院（320床）
戦略期間: 令和7年度～令和9年度（法人中期経営計画と連動）
前提資料: 法人経営環境分析レポート、月次経営分析レポート（202602）、全8件のPDF抽出データ

---

1. 戦略的ポジショニング

1.1 法人内における大橋病院の位置づけ

大橋病院は、法人の3病院体制の中で以下の独自のポジションを占めている。

観点	大橋病院の位置づけ	根拠
収益効率	3病院中最高	入院単価102,345円（最高）、平均在院日数8.8日（最短）
規模	3病院中最小	320床（大森800床、佐倉380床）
投資配分	限定的	大森再開発194億円に投資集中。大橋は自力更生
収益改善	唯一の増益	粗利益前年比+122.4%（大森△32.9%、佐倉△26.4%）
地域的役割	区西南部の基幹	救急謝絶率19.0%（3病院最良）、地域医療支援病院
外部評価	同クラス上位	急性期1算定病院（n=270）の中で「短在院・高単価・高稼働」で黒字維持

1.2 大橋病院の差別化要因

強み（法人内・同クラス比較）
- 入院単価の圧倒的優位（同クラス平均71,439円に対し100,719円 = 141%）
- 平均在院日数の短さ（同クラス平均12.9日に対し8.9日 = 69%）
- DPC標準病院群での高効率運営
- 救急受入体制の充実（謝絶率19.0%は目標30%未満を大幅クリア）

弱み（改善余地のある領域）
- 外来患者数の構造的減少（累計△8.5%、予算比1日平均△58人）
- 外来単価が佐倉を下回る（22,000円 vs 27,800円）[!]
- 初診率7.6%（目標10%未達）
- 整形外科の紹介激減（△543件、全科最大）

1.3 戦略コンセプト

「限られた投資の中での収益最大化 ― 高効率・高単価モデルの深化」

法人が大森再開発に投資を集中させる3年間（R7-R9）、大橋病院は大規模設備投資なしに収益を最大化する戦略を取る。具体的には：
・既存設備（ダヴィンチ、ICU/HCU/SCU）の稼働最大化
・診療報酬改定効果の確実な取り込み
・外来患者数の回復による量の確保
・医療経費の抑制による利益率改善

---

2. 重点施策（5項目）

施策1: 外来患者数の回復と外来収入の底上げ

【背景】
外来患者数は累計△8.5%（1日平均852人 vs 予算910人）と大幅減少が続いている（月次分析レポート202602）。外来単価+11.6%で総額はかろうじて+2.1%を維持しているが、量の減少を単価だけで補い続けるのは限界がある。特に初診率7.6%（目標10%）の未達は、新規患者の流入不足を示している。

【収益インパクト】
・現在の外来収入: 約51.3億円/年（4-2月累計）
・1日平均患者数を予算水準（910人）に回復させた場合の増収試算:
  ・追加患者数: 58人/日 × 診療日数約240日 = 年間13,920人
  ・増収額: 13,920人 × 22,841円（外来単価） = 約3.2億円/年

【実行ステップ】
紹介患者の回復: 整形外科の紹介激減（△543件）への集中対策
  ・整形外科の紹介元医療機関への訪問強化
  ・紹介減少の原因分析（医師の退職・異動、競合病院の台頭、疾患構造の変化等）
  ・逆紹介後のフォロー体制見直し（逆紹介した患者の再紹介率のモニタリング）
Web予約システム（やくばと）の活用促進: 令和8年度の組織目標に明記
  ・紹介元医療機関への周知活動の強化
  ・紹介→予約→受診のフロー簡素化
第3土曜日の診療日化の効果検証と継続: 上期実績で外来収入増に寄与
広報強化: ホームページ閲覧数+5万件の勢いを継続、SNS活用拡大

【現場負荷】 [!][!]（中程度）
地域連携室と整形外科の負荷が中心。医師による医療機関訪問は月平均11件（目標達成済み）の継続が基本。Web予約はむしろ電話対応の軽減が期待でき、長期的には負荷軽減に寄与する。

施策2: ダヴィンチ手術の症例拡大と高度手術の推進

【背景】
ロボット支援手術（ダヴィンチ）は月平均10.2件（目標月10件達成、上期事業運営状況）で順調に推移。令和8年度の組織目標では「外科3術式、泌尿器科2術式の届出」が計画されており、適応拡大による増収が見込める。手術部門全体でも年間6,336件（前年比+174件、+2.8%）と成長を維持している。

【収益インパクト】
・ダヴィンチ手術1件あたりの収入増（開腹・腹腔鏡比）: 推定+30～50万円（DPC点数差・手術材料費差引後）
・新規5術式の届出により月3～5件の追加が見込まれる場合:
  ・年間追加: 36～60件 × 30～50万円 = 約1,080～3,000万円/年

・急性期充実体制加算の維持にも手術件数の増加が寄与（全身麻酔3,261件、基準2,000件を大幅超過）

【実行ステップ】
外科3術式（具体的術式の特定・届出準備）
泌尿器科2術式（具体的術式の特定・届出準備）
手術室のスケジュール最適化（ダヴィンチ枠の確保）
術前カンファレンスでのダヴィンチ適応症例の積極的な検討
手術実績のDPCデータ分析によるベンチマーク比較

【現場負荷】 [!][!][!]（高い ー ただし段階的導入で緩和）
手術室看護師・臨床工学技士のロボット手術トレーニングが必要。新術式ごとに習熟期間を設け、段階的に導入することで負荷を分散させる。医師の学習曲線を考慮し、初期は症例選定を慎重に行う。

施策3: 診療報酬改定効果の最大化（算定漏れ防止）

【背景】
令和8年度診療報酬改定により増収が見込まれる。この効果を確実に取り込むためには、算定要件の充足と算定漏れの防止が不可欠である。

【収益インパクト】
・DPC係数改定等による増収効果が見込まれる
・施設基準の維持・取得による加算確保が重要

【実行ステップ】
施設基準の総点検: R8改定で変更された施設基準の一覧化と充足確認
算定漏れ監査: 以下の項目を重点チェック
・入退院支援加算（資料8で算定状況モニタリング済み）
・急性期充実体制加算の要件維持
・地域医療支援病院の要件維持（紹介率87.1%で十分クリア）
・外来化学療法加算（資料2で月次モニタリング済み）
保険算定業務の効率化: 施設基準管理システム（大森病院が9月導入済み）の大橋への展開
DPC期間II以内退院率の改善: 短在院日数・高単価モデルの強化
医事課スタッフへの改定内容研修: 新算定コード・変更点の周知

【現場負荷】 [!]（低い）
医事課が主体の事務的対応が中心。施設基準管理システムの導入はむしろ業務負荷の軽減に寄与する。臨床現場への影響は、記録・指示の一部変更にとどまる。

施策4: 医療経費の抑制（3病院共同の取り組み活用）

【背景】
法人全体で医療経費は前年比+5.3%（+15.6億円）の増加が予算化されている（事業活動収支予算書）。薬品費165.1億円（+3.2%）、診療材料費113.2億円（+9.2%）が増加の主因である。上期実績でも医療経費は予算を上回っており、収支圧迫の最大要因となっている。

【収益インパクト】
・大橋病院の医療経費（月次分析レポートより推定）: 約50～55億円/年
・1%の削減で: 約5,000～5,500万円/年の改善
・3病院共同の購買交渉で2%削減を達成した場合: 約1～1.1億円/年

【実行ステップ】

3病院薬剤部長会議の活用: バイオシミラーへの切り替え推進、採用薬の統一
3病院用度課実務担当者会議の活用: 診療材料の共同価格交渉、ベンチマークデータに基づく購買最適化
後発医薬品指数の維持: 現在96.1%（資料6）で高水準。金額ベースでの使用率もモニタリング
高額薬品の使用適正化: 化学療法3科（外科・泌尿器科・消化器内科）の高額薬剤使用を費用対効果で検証
SPD（院内物流管理）の最適化: 在庫回転率の改善、使用期限切れロスの削減

【現場負荷】 [!]（低い）
薬剤部・用度課が主体。臨床現場への影響は、バイオシミラー切替時の医師・患者への説明が主。3病院共同の取り組みを活用することで、大橋病院単独での交渉負荷を軽減できる。

---

3. 3年ロードマップ（中期計画と連動）

R7年度（令和7年度）— 基盤固めの年

四半期	重点アクション	期待効果
Q1-Q2（実施済み）	ダヴィンチ月10件達成、救急謝絶率19%実現	手術収入+2.8%、救急受入体制確立
Q3	外来患者数回復策の始動、Web予約システム導入、第3土曜診療継続	外来減少の下げ止まり
Q4	整形外科紹介回復策の集中実施、R8改定対応準備	紹介件数の底打ち
年度目標	粗利益率: 0.8%→1.5%以上	前年度対比の改善継続

R8年度（令和8年度）— 改定効果の刈り取り

四半期	重点アクション	期待効果
Q1	R8診療報酬改定の施設基準届出・算定対応	改定効果の早期取り込み
Q2	ダヴィンチ新5術式の段階的導入開始	手術件数・収入の上積み
Q3	算定漏れ監査（中間チェック）、外来患者数の進捗評価	改定効果の最大化確認
Q4	3病院合同戦略会議でのベンチマーク報告、R9計画策定	成果の法人内共有
年度目標	改定効果+3億円の確実な取り込み、粗利益率2%以上	法人の黒字転換に貢献

R9年度（令和9年度）— 収益の安定化と次期への布石

四半期	重点アクション	期待効果
Q1-Q2	大森新外来棟竣工（R9.9月予定）に伴う患者動態変化の分析	地域内での役割再定義
Q3	大橋病院の中長期設備更新計画の策定（次期中計R10-12に向け）	投資余力の回復後の戦略準備
Q4	3年間の成果検証、次期中期計画への提言	エビデンスに基づく戦略見直し
年度目標	粗利益率3%以上、外来患者数の予算水準回復	持続可能な収益構造の確立

---

4. リスクシナリオと対策

シナリオA: 外来患者数の減少が加速した場合

・影響: 1日平均△100人で年間約5.5億円の減収リスク
・対策: 紹介元医療機関との関係強化（訪問活動の倍増）、新規診療科の外来枠拡大、オンライン診療の導入検討
・代替策: 外来化学療法の拡大（高単価・高収益）で量の減少を補完

シナリオB: 大森再開発の工費超過が法人財務を直撃した場合

・影響: 大橋病院の通常設備投資がさらに圧縮される可能性
・対策: 優先度の高い設備更新のみに絞り込み、リース活用の検討
・代替策: DPC機能評価係数の向上で増収を図り、設備投資財源を自力確保

シナリオC: 物価高騰が想定以上に長期化した場合

・影響: 医療経費率のさらなる上昇、粗利益の圧迫
・対策: 3病院共同の価格交渉強化、SPD業者の見直し、バイオシミラー使用率の引き上げ
・代替策: 室料差額の見直し（法人が自助努力として明記）

---

5. 施策別収益インパクトまとめ

施策	年間収益インパクト	実現時期	確度	現場負荷
外来患者数回復	+1～3.2億円	R7 Q3～R9	中	[!][!]
ダヴィンチ拡大	+1,000～3,000万円	R8 Q2～	高	[!][!][!]
診療報酬改定効果	増収（施設基準維持等）	R8 Q1	高	[!]
医療経費抑制	+5,000万～1億円	R7 Q3～	中	[!]
合計	+1.6億～4.5億円/年（改定効果除く）	ー	ー	ー

【解釈】全施策が計画通りに進んだ場合、診療報酬改定効果を除いても年間+1.6～4.5億円の収益改善が見込まれる。これに改定効果が加わることで、法人の中期計画がR8に+3.5億円、R9に+7.7億円の黒字を想定していることを踏まえ、大橋病院は法人全体の黒字転換に大きく貢献する。

出典一覧

略称	正式名称
月次分析レポート202602	大橋病院 2025年度2月実績 経営分析レポート
README	business-strategy リポジトリ README.md
事業活動収支予算書	令和7年度事業活動収支予算書.pdf

法人全体収支計画	法人全体収支計画_新中期経営計画(令和7年度~令和9年度).pdf
上期事業運営状況	令和7年度上期の事業運営状況について.pdf
組織目標 各所属	組織目標（年度運営方針）令和8年度 各所属.pdf